血常规

模拟数据 • 仅供软件测试 • 非真实医疗文书

患者：测试患者A（虚构）　　性别：男　　年龄：38岁

测试患者编号：ONCO-DEMO-001　　场景：肺癌诊疗资料模拟

检查日期：2026-10-10　　报告日期：2026-10-11　　编号：SIM-01

标本 / 检查方式：静脉全血 / 治疗前评估

检查项目	结果	单位	示例参考范围	标记
白细胞	7.80	10^9/L	3.50-9.50	正常
红细胞	3.92	10^12/L	4.30-5.80	偏低
血红蛋白	112	g/L	130-175	偏低
红细胞压积	34.1	%	40.0-50.0	偏低
平均红细胞体积	87.0	fL	82.0-100.0	正常
血小板	328	10^9/L	125-350	正常
中性粒细胞比例	68.0	%	40.0-75.0	正常

模拟结果摘要

模拟结果：红细胞、血红蛋白及红细胞压积降低，呈贫血表现。

该结果不能单独确定贫血原因。

全部身份、数值和结论均为人为编造，未采集真实患者资料。
参考范围仅为测试示例，实际范围依实验室、方法和患者情况而异。
无真实医院、医师签名或印章；不得用于诊断、用药、报销或证明。

肝肾功能与电解质

模拟数据 • 仅供软件测试 • 非真实医疗文书

患者：测试患者A（虚构）　　性别：男　　年龄：38岁

测试患者编号：ONCO-DEMO-001　　场景：肺癌诊疗资料模拟

检查日期：2026-10-10　　报告日期：2026-10-11　　编号：SIM-02

标本 / 检查方式：静脉血清 / 治疗前评估

检查项目	结果	单位	示例参考范围	标记
ALT	32	U/L	9-50	正常
AST	29	U/L	15-40	正常
白蛋白	34.0	g/L	40-55	偏低
总胆红素	13.5	μmol/L	0-21	正常
碱性磷酸酶 ALP	168	U/L	45-125	偏高
肌酐	82	μmol/L	57-97	正常
尿素	5.6	mmol/L	3.1-8.0	正常
钾	4.1	mmol/L	3.5-5.3	正常
钠	138	mmol/L	137-147	正常

模拟结果摘要

模拟结果：白蛋白降低、ALP升高，其余所列项目在示例范围内。

需结合营养状态及肝脏、骨骼影像判断，不能单独推断转移。

全部身份、数值和结论均为人为编造，未采集真实患者资料。
参考范围仅为测试示例，实际范围依实验室、方法和患者情况而异。
无真实医院、医师签名或印章；不得用于诊断、用药、报销或证明。

凝血功能

模拟数据 • 仅供软件测试 • 非真实医疗文书

患者：测试患者A（虚构）　　性别：男　　年龄：38岁

测试患者编号：ONCO-DEMO-001　　场景：肺癌诊疗资料模拟

检查日期：2026-10-10　　报告日期：2026-10-11　　编号：SIM-03

标本 / 检查方式：枸橼酸钠抗凝血浆

检查项目	结果	单位	示例参考范围	标记
凝血酶原时间 PT	12.6	秒	11.0-14.0	正常
国际标准化比值 INR	1.02	-	0.80-1.20	正常
APTT	31.5	秒	25.0-35.0	正常
纤维蛋白原	4.6	g/L	2.0-4.0	偏高
D-二聚体	0.92	mg/L FEU	<0.50	偏高

模拟结果摘要

模拟结果：纤维蛋白原及D-二聚体升高。

D-二聚体异常不等于已确诊血栓，本病例未设定血栓诊断。

全部身份、数值和结论均为人为编造，未采集真实患者资料。
参考范围仅为测试示例，实际范围依实验室、方法和患者情况而异。
无真实医院、医师签名或印章；不得用于诊断、用药、报销或证明。

肿瘤相关标志物

模拟数据 • 仅供软件测试 • 非真实医疗文书

患者：测试患者A（虚构）　　性别：男　　年龄：38岁

测试患者编号：ONCO-DEMO-001　　场景：肺癌诊疗资料模拟

检查日期：2026-10-10　　报告日期：2026-10-11　　编号：SIM-04

标本 / 检查方式：静脉血清

检查项目	结果	单位	示例参考范围	标记
癌胚抗原 CEA	42.6	ng/mL	<5.0	偏高
CYFRA21-1	6.8	ng/mL	<3.3	偏高
神经元特异性烯醇化酶	13.2	ng/mL	<16.3	正常

模拟结果摘要

模拟结果：CEA及CYFRA21-1升高。

肿瘤标志物仅作配套测试数据，不能独立诊断癌症或判断分期。

全部身份、数值和结论均为人为编造，未采集真实患者资料。
参考范围仅为测试示例，实际范围依实验室、方法和患者情况而异。
无真实医院、医师签名或印章；不得用于诊断、用药、报销或证明。

胸部增强CT

模拟数据 • 仅供软件测试 • 非真实医疗文书

患者：测试患者A（虚构）　　性别：男　　年龄：38岁

测试患者编号：ONCO-DEMO-001　　场景：肺癌诊疗资料模拟

检查日期：2026-10-10　　报告日期：2026-10-11　　编号：SIM-05

标本 / 检查方式：胸部CT平扫及增强 / 虚构文字描述

检查描述与模拟结论

临床背景：持续咳嗽约6周，偶有痰中带血，近2个月体重下降约4 kg。

检查所见：右肺上叶见约46 × 38 mm不规则软组织肿块，边缘分叶并见毛刺。

增强后呈不均匀强化；右肺门及纵隔见增大淋巴结，最大短径约16 mm。

未设定明显胸腔积液。

模拟结论：右肺上叶占位，考虑恶性肿瘤；肺门及纵隔淋巴结可疑受累。

影像不能替代病理。与第09份穿刺病理报告对应，不附真实CT图像。

全部身份、数值和结论均为人为编造，未采集真实患者资料。
参考范围仅为测试示例，实际范围依实验室、方法和患者情况而异。
无真实医院、医师签名或印章；不得用于诊断、用药、报销或证明。

腹部增强CT

模拟数据 • 仅供软件测试 • 非真实医疗文书

患者：测试患者A（虚构）　　性别：男　　年龄：38岁

测试患者编号：ONCO-DEMO-001　　场景：肺癌诊疗资料模拟

检查日期：2026-10-10　　报告日期：2026-10-11　　编号：SIM-06

标本 / 检查方式：腹部CT平扫及增强 / 虚构文字描述

检查描述与模拟结论

检查所见：肝右叶见两处低密度灶，约18 mm及12 mm，增强后呈环形强化。

其余腹部脏器未设定明显异常，未设定腹水。

模拟结论：结合肺部恶性肿瘤背景，肝内病灶可疑转移。

肝病灶未在本资料中进行活检，不能写作病理确诊的肝转移。

本页仅为模拟影像文字报告，不附真实CT图像。

全部身份、数值和结论均为人为编造，未采集真实患者资料。
参考范围仅为测试示例，实际范围依实验室、方法和患者情况而异。
无真实医院、医师签名或印章；不得用于诊断、用药、报销或证明。

颅脑增强MRI

模拟数据 • 仅供软件测试 • 非真实医疗文书

患者：测试患者A（虚构）　　性别：男　　年龄：38岁

测试患者编号：ONCO-DEMO-001　　场景：肺癌诊疗资料模拟

检查日期：2026-10-10　　报告日期：2026-10-11　　编号：SIM-07

标本 / 检查方式：颅脑MRI平扫及增强 / 虚构文字描述

检查描述与模拟结论

检查所见：脑实质未设定异常强化结节，未见明显占位效应。

脑室系统未设定扩张，中线结构居中。

模拟结论：本次模拟检查未设定明确颅内转移征象。

未见征象不代表排除所有微小病灶。本页不附真实MRI图像。

全部身份、数值和结论均为人为编造，未采集真实患者资料。
参考范围仅为测试示例，实际范围依实验室、方法和患者情况而异。
无真实医院、医师签名或印章；不得用于诊断、用药、报销或证明。

全身骨显像

模拟数据 • 仅供软件测试 • 非真实医疗文书

患者：测试患者A（虚构）　　性别：男　　年龄：38岁

测试患者编号：ONCO-DEMO-001　　场景：肺癌诊疗资料模拟

检查日期：2026-10-10　　报告日期：2026-10-11　　编号：SIM-08

标本 / 检查方式：核医学骨显像 / 虚构文字描述

检查描述与模拟结论

检查所见：胸椎T8椎体及右侧髂骨见局灶性放射性摄取增高。

其余骨骼未设定明显异常摄取灶。

模拟结论：上述部位可疑骨转移，需结合局部CT或MRI进一步核实。

本资料未设定骨病灶病理确认，也未提供实际核医学图像。

全部身份、数值和结论均为人为编造，未采集真实患者资料。
参考范围仅为测试示例，实际范围依实验室、方法和患者情况而异。
无真实医院、医师签名或印章；不得用于诊断、用药、报销或证明。

肺组织穿刺病理

模拟数据 • 仅供软件测试 • 非真实医疗文书

患者：测试患者A（虚构）　　性别：男　　年龄：38岁

测试患者编号：ONCO-DEMO-001　　场景：肺癌诊疗资料模拟

检查日期：2026-10-10　　报告日期：2026-10-11　　编号：SIM-09

标本 / 检查方式：右肺上叶肿块 / CT引导下粗针穿刺

检查描述与模拟结论

送检材料：灰白色组织条3条，均为虚构标本。

镜下描述：异型上皮细胞呈腺样排列，核增大，核仁明显，局部可见黏液。

免疫组化设定：TTF-1阳性、Napsin A阳性、CK7阳性、p40阴性。

模拟病理诊断：（右肺上叶穿刺组织）腺癌，结合部位符合肺腺癌。

小标本仅代表取样组织；本页无真实显微照片、病理医师签名或印章。

全部身份、数值和结论均为人为编造，未采集真实患者资料。
参考范围仅为测试示例，实际范围依实验室、方法和患者情况而异。
无真实医院、医师签名或印章；不得用于诊断、用药、报销或证明。

肿瘤分子检测

模拟数据 • 仅供软件测试 • 非真实医疗文书

患者：测试患者A（虚构）　　性别：男　　年龄：38岁

测试患者编号：ONCO-DEMO-001　　场景：肺癌诊疗资料模拟

检查日期：2026-10-10　　报告日期：2026-10-11　　编号：SIM-10

标本 / 检查方式：肺穿刺组织 / 虚构分子检测与免疫组化

检查描述与模拟结论

检测设定：EGFR外显子19缺失变异检出。

ALK融合未检出，ROS1融合未检出。

PD-L1免疫组化：肿瘤细胞阳性比例评分（TPS）10%。

本页仅列出模拟项目，不代表完成了全部肿瘤基因检测。

结果用于测试App展示和检索，不提供用药方案或剂量。

全部身份、数值和结论均为人为编造，未采集真实患者资料。
参考范围仅为测试示例，实际范围依实验室、方法和患者情况而异。
无真实医院、医师签名或印章；不得用于诊断、用药、报销或证明。

医生诊断意见书（模拟）

模拟数据 • 仅供软件测试 • 非真实医疗文书

患者：测试患者A（虚构）　　性别：男　　年龄：38岁

测试患者编号：ONCO-DEMO-001　　场景：肺癌诊疗资料模拟

检查日期：2026-10-10　　报告日期：2026-10-11　　编号：SIM-11

标本 / 检查方式：综合第01-10份模拟检查 / 无医疗效力

检查描述与模拟结论

一、主诉与病史：咳嗽6周，间断痰中带血，近2个月体重下降约4 kg。

二、主要诊断：右肺上叶肺腺癌（依据第09份模拟穿刺病理）。

三、临床评估：右肺门及纵隔淋巴结可疑受累；肝脏及骨骼存在可疑转移灶。

远处病灶尚未完成确认，本诊断书不指定最终TNM分期。

四、伴随问题：贫血表现、低白蛋白血症；具体原因仍待评估。

五、分子特征：模拟EGFR外显子19缺失检出，PD-L1 TPS为10%。

六、诊疗意见（场景文本）：完成分期核实及肿瘤多学科评估后，讨论治疗。

本资料未设定既往抗肿瘤治疗；不含具体药物、剂量或个人治疗建议。

出具身份：虚构医生角色 / 未签署 / 无真实医疗机构。

特别声明：此为软件测试用诊断书样例，不是用户本人的诊断。

全部身份、数值和结论均为人为编造，未采集真实患者资料。
参考范围仅为测试示例，实际范围依实验室、方法和患者情况而异。
无真实医院、医师签名或印章；不得用于诊断、用药、报销或证明。